

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	26026011
Разрешение №	11-16281, 03.10.2011
Одобрение №	8, 22.12.2011

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КХТ-булин 120 g/l инжекционен разтвор

CHF-bulin 120 g/l sol. for inj.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява КХТ-булин и за какво се използва
2. Преди да използвате КХТ-булин
3. Как да използвате КХТ-булин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КХТ-булин
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КХТ-БУЛИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

КХТ-булин е хиперимунен човешки имуноглобулин. Изготвен е от плазмата на здрави донори, имунизирани с инактивирана ваксина срещу вируса на Кримска хеморагична треска. Съдържа човешки протеини 100 – 170 g/l, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Концентрацията на специфичните антитела срещу вируса на Кримска хеморагична треска (КХТ) е 6 до 10 пъти по-висока в сравнение с изходната плазма.

Използва се за:



- **Профилактика на лица, неимунизирани с ваксина против КХТ, които са били в контакт с болни или съмнително болни от КХТ**
- **При съмнение за заболяване от КХТ – в ендемични райони, всяко неизяснено заболяване по време на епидемичния сезон, което започва с висока температура със или без кръвоизливи и което е предшествано от ухапване от кърлежи.**
- **За лечение на болни от КХТ, независимо от това кога е започнало заболяването и каква е неговата тежест**

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КХТ-БУЛИН

Не използвайте КХТ-булин

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към имуноглобулини или към някоя от съставките на КХТ-булин
- ако имате непоносимост към хомоложни имуноглобулини, особено в редките случаи на IgA дефицит, когато може да имате има атитела срещу IgA.

КХТ – булин не бива да се прилага мускулно в случаи на остра тромбоцитопения и при други разстройства на хемостазата.

Обърнете специално внимание при употребата на КХТ-булин

Ако КХТ-булин случайно се инжектира в кръвоносен съд, пациентът може да получи шок.

Препоръчаният начин на инжектиране трябва да се спазва. Пациентът трябва да се наблюдава и проследява по време на инжектирането на продукта за странични реакции.

Истинските реакции на свръхчувствителност са рядкост. Те могат да се наблюдават в много редките случаи на IgA недостатъчност при пациенти с анти IgA антитела. Тези пациенти трябва да се третират внимателно.

Пациентите трябва да се наблюдават най- малко 20 минути след инжектиране на продукта.



При съмнение за алергичен или анафилактичен тип реакция се препоръчва незабавно спиране на инжектирането. В случай на шок лечението трябва да следва указанията за съвременна противошокова терапия.

Когато се прилагат лекарствени продукти, получени от човешка кръв или плазма, не може да бъде изключено изцяло предаването на трансмисивни инфекции. Това се отнася също за патогени с неизвестна до сега природа. Рискът от пренос на инфекциозни агенти е намален чрез:

- подбор на дарителите чрез медицинско интервю и скрининг на индивидуалните дарявания и плазмени пулове за HBsAg и антитела срещу HIV и HCV
- изследване на плазмените пулове за HCV геномен материал
- инактивиращи/отстраняващи процедури, включени в производствения процес, валидиран чрез моделен вирус. Тези процедури се отнасят за вируса на HCV, HBV, HIV (вирус с обвивка)

Препоръчва се името и партидният номер на КХТ – булин да бъдат записвани при всяко приложение на продукта.

Употреба на други лекарства.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта или Ви е правена ваксинация през последните шест седмици.

Приложението на имуноглобулини като КХТ –булин може да доведе до намаляване на ефекта от приложение на някои живи вирусни ваксини (морбили, рубеола, заушка , варицела). Това налага да се изчака прилагането на живи атенюирани ваксини до три месеца след приложението на КХТ-булин и една година, ако трябва да се ваксинирате срещу морбили.

Взаимодействие със серологични тестове

След инжектиране на имуноглобулини временното увеличение на различни пасивно преминали антитела в кръвта на пациента може да доведе до погрешни положителни резултати в серологични тестове.



Пасивно предаване на антитела към еритроцитни антигени напр. А, В, D може да взаимодейства с някои серологични тестове (ретикулоцитно броене, хаптоглобин и Кумбс тест).

Бременност и кърмене

Уведомете Вашият лекар ако сте бременна или кърмите.

Безопасността на този лекарствен продукт за употреба при бременност не е установена в контролирани клинични проучвания и за това се прилага само ако е показан при бременни и кърмачки. Продължителният клиничен опит с имуноглобулини показва, че не се очакват неблагоприятни ефекти върху протичането на бременността и/или върху развитието на плода и новороденото. Имуноглобулините се екскретират с майчината кърма и могат да способстват пренасянето на защитни антитела у новороденото.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма данни, че КХТ-булин може да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КХТ-БУЛИН

КХТ-булин е стерилен разтвор за мускулно приложение. Дозировката и скоростта на вливане ще определи Вашият лекуващ лекар съобразно Вашето заболяване.

- преди употреба продуктът трябва да се затопли до телесна температура.
- разтворът трябва да бъде бистър, прозрачен, бледожълт до леко опалесциращ.
- останали неизползвани количества се изхвърлят по подходящ начин.
- ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.



Ако са Ви приложили повече от необходимата доза КХТ-булин:

Последствия от предозиране не са известни.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КХТ-булин може да предизвика нежелани реакции, въпреки , че не всеки ги получава.

Най-често продуктът се понася без реакция. В някои случаи на мястото на инжектирането се чувства зачервяване, подуване, обрив, болка и може да настъпи краткотрайно повишение на температурата или студени тръпки. Рядко се получават кожни реакции. В редки случаи може да се наблюдават гадене, повръщане, треска, артралгия, главоболие, болка ниско в гърба, хипотензия, тахикардия и алергични или анафилактични реакции, включително шок.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КХТ-БУЛИН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте КХТ-булин след срока на годност, указан на етикета и на картонената опаковка. Срокът на годност изтича на последния ден на указания месец.

Да се съхранява от +2°C до +8°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Да не се замразява.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Какво съдържа КХТ-булин

- Активното вещество в КХТ-булин е хиперимунен имуноглобулин против Кримска хеморагична треска.
- Другите съставки са натриев хлорид и вода за инжекции.

Как изглежда КХТ-булин и какво съдържа опаковката?

КХТ-булин е инжекционен разтвор и се предлага в стъклени ампули от 3 ml.

Разтворът е бистър, бледо жълт с лека опалесценция

Притежател на разрешението за употреба

Бул Био – НЦЗПБ ЕООД,

София 1504, бул. " Янко Сакъзов " №26

тел: 02 944 61 91

факс: 943 30 75

e-mail: bulbio@bulbio.com

Дата на последното одобрение на листовката:

12. 2011 г.

